PATRÍCIO ALMEIDA

SAÚDE NO ESTADO DO AMAPÁ: LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL E ESTUDO ANALÍTICO PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2026/2027

Série histórica 2022–2026 com base em dados públicos (DATASUS, SIOPS, IBGE)

MACAPÁ

2026

PATRÍCIO ALMEIDA

SAÚDE NO ESTADO DO AMAPÁ: LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL E ESTUDO ANALÍTICO PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2026/2027

Série histórica 2022–2026 com base em dados públicos (DATASUS, SIOPS, IBGE)

Estudo analítico elaborado como subsídio técnico à equipe de transição de governo do Estado do Amapá, área da saúde (Secretaria de Estado da Saúde – SESA/AP), com base em dados públicos extraídos em 6 de novembro de 2026.

MACAPÁ

2026

RESUMO

Este estudo apresenta o levantamento da produção hospitalar e ambulatorial, da rede física, da força de trabalho, do financiamento e dos indicadores vitais da saúde no Estado do Amapá na série histórica 2022–2026, com a finalidade de subsidiar a transição de governo 2026/2027 na Secretaria de Estado da Saúde (SESA/AP). Os dados foram extraídos de bases públicas (DATASUS/TABNET: SIH, SIA, CNES, SIM e SINASC; SIOPS; IBGE/SIDRA; edital do concurso SESA 001/2026) e tabulados em planilha com 129 tabelas. Entre 2022 e 2025, as internações SUS cresceram 40,1% (41.312 para 57.873 AIH) e o valor ambulatorial 93,3% (R$ 77,0 milhões para R$ 148,7 milhões); os leitos SUS aumentaram 14,8% e o número de médicos cadastrados 54%; a despesa estadual com saúde por habitante subiu 84,5% e é a maior do país. Permanecem, contudo, o menor valor médio de internação entre as unidades da federação, apenas 2,3% de internações de alta complexidade, mortalidade infantil de 17,8 por mil nascidos vivos (3ª maior do Brasil em 2024) e dependência de prestadores externos. Identificou-se crescimento atípico do faturamento de procedimentos vasculares (de R$ 15 mil em 2022 para R$ 25,6 milhões em 2025 no SIA, com 7.375 internações de trombectomia venosa de permanência zero em 2025) e divergência entre leitos de UTI existentes (139) e cadastrados como SUS (19). O estudo conclui com pontos de atenção, lista de documentos a requisitar e agenda de prioridades para os primeiros cem dias da nova gestão.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Amapá; produção hospitalar; produção ambulatorial; financiamento da saúde; transição de governo.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Nascidos vivos por tipo de parto, Amapá, 2022–2025.....16
Figura 2 – Taxa de mortalidade infantil, Amapá e Brasil, 2022–2025.....17
Figura 3 – Internações SUS (AIH aprovadas), Amapá, 2022–2026.....18
Figura 4 – Valor aprovado da produção hospitalar e ambulatorial, Amapá, 2022–2026..... 19
Figura 5 – Internações (AIH) por estabelecimento, Amapá, 2025.....20
Figura 6 – Internações por capítulo da CID-10, Amapá, 2025.....22
Figura 7 – Internações SUS por 100 habitantes, por UF de internação, 2025.....24
Figura 8 – Leitos de internação SUS por especialidade, Amapá, 2022–2026.....29
Figura 9 – Leitos de UTI existentes, Amapá, 2022–2026.....30
Figura 10 – Médicos e enfermeiros cadastrados no CNES, Amapá, 2022–2026.....32
Figura 11 – Percentual da receita própria aplicada em ASPS, Estado do Amapá, 2022–2025..... 34
Figura 12 – Despesa do Estado com saúde por habitante, Amapá, 2022–2025.....35
Figura 13 – Procedimentos vasculares: valor ambulatorial e internações circulatórias, Amapá, 2022–2026.....37

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – População residente estimada por município, Amapá, 2025.....15
Tabela 2 – Indicadores materno-infantis selecionados, Amapá, 2022–2025.....17
Tabela 3 – Internações SUS no Amapá por ano de processamento, 2022–2026.....18
Tabela 4 – Produção hospitalar por estabelecimento, Amapá, 2022, 2025 e 2026...19
Tabela 5 – Internações por capítulo da CID-10, Amapá, 2022 e 2025.....21
Tabela 6 – Internações de residentes do Amapá e internações realizadas no Amapá, 2022–2025..... 23
Tabela 7 – Indicadores de produção hospitalar e ambulatorial: Amapá, Brasil e posição entre as UFs, 2024–2025.....23
Tabela 8 – Produção ambulatorial SUS no Amapá por ano de processamento, 2022–2026..... 25
Tabela 9 – Valor aprovado da produção ambulatorial por subgrupo de procedimento, Amapá, 2022 e 2025.....25
Tabela 10 – Leitos de internação SUS por especialidade, Amapá, dez./2022 a set./2026.....28
Tabela 11 – Leitos complementares existentes e SUS, Amapá, dez./2022 e set./2026 29
Tabela 12 – Equipamentos selecionados cadastrados no CNES, Amapá, set./2026 30
Tabela 13 – Profissionais de saúde cadastrados no CNES por ocupação, Amapá, dez./2022 a set./2026.....32
Tabela 14 – Indicadores SIOPS do Estado do Amapá, 2022–2026.....34

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AIH	Autorização de Internação Hospitalar
Alap	Assembleia Legislativa do Estado do Amapá
APAC	Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade
ASPS	Ações e Serviços Públicos de Saúde
BPA	Boletim de Produção Ambulatorial
CBO	Classificação Brasileira de Ocupações
CID-10	Classificação Estatística Internacional de Doenças, 10ª revisão
CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
DATASUS	Departamento de Informática do SUS
DENASUS	Departamento Nacional de Auditoria do SUS
Ebserh	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
FAEC	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação
FES	Fundo Estadual de Saúde
FNS	Fundo Nacional de Saúde
HCA	Hospital da Criança e do Adolescente
HCAL	Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima
HE	Hospital de Emergência
HU-UNIFAP	Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
LOA	Lei Orçamentária Anual
MAC	Média e Alta Complexidade
OCI	Oferta de Cuidados Integrados
PCCS	Plano de Cargos, Carreiras e Salários
PLOA	Projeto de Lei Orçamentária Anual
SESA/AP	Secretaria de Estado da Saúde do Amapá
SIA/SUS	Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS
SIH/SUS	Sistema de Informações Hospitalares do SUS
SIM	Sistema de Informações sobre Mortalidade
SINASC	Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
SIOPS	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
SUS	Sistema Único de Saúde
TCE-AP	Tribunal de Contas do Estado do Amapá

TFD	Tratamento Fora de Domicílio
TMI	Taxa de mortalidade infantil
UCI	Unidade de Cuidados Intermediários
UF	Unidade da Federação
UPA	Unidade de Pronto Atendimento
UTI	Unidade de Terapia Intensiva

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..... 10
1.1 Objetivo e contexto..... 10
1.2 Objeto..... 10
1.3 Período..... 11
1.4 Fontes e extração..... 11
1.5 Limitações..... 11
2 SÍNTESE DOS ACHADOS..... 12
3 DEMOGRAFIA E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO..... 15
3.1 População..... 15
3.2 Nascimentos e saúde materno-infantil..... 15
3.3 Mortalidade geral e causas..... 17
4 PRODUÇÃO HOSPITALAR (SIH/SUS)..... 18
4.1 Série histórica..... 18
4.2 Produção por estabelecimento..... 19
4.3 Perfil de morbidade..... 21
4.4 Fluxo de pacientes: residência versus local de internação..... 23
4.5 Comparativo entre UFs..... 23
5 PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SIA/SUS)..... 25
5.1 Série histórica..... 25
5.2 Composição por subgrupo e procedimento..... 25
5.3 Linhas de cuidado de alto custo..... 26
5.4 Distribuição territorial..... 27
6 REDE FÍSICA E EQUIPAMENTOS (CNES)..... 28
6.1 Estabelecimentos..... 28
6.2 Leitos..... 28
6.3 Equipamentos..... 30
7 FORÇA DE TRABALHO..... 32
8 FINANCIAMENTO..... 34
8.1 SIOPS: indicadores do Estado..... 34
8.2 Orçamento estadual e recursos federais..... 35
9 PONTOS DE ATENÇÃO PARA A TRANSIÇÃO..... 37

9.1 Procedimentos vasculares: crescimento atípico de faturamento (prioridade máxima).....37
9.2 Cadastro de leitos e habilitações.....38
9.3 Relações com prestadores estratégicos.....38
9.4 Rede de urgência, sazonalidade respiratória e pediatria.....38
9.5 Mortalidade infantil e atenção materna.....38
9.6 Alta complexidade e TFD.....39
9.7 Pessoal.....39
10 RECOMENDAÇÕES E AGENDA DOS PRIMEIROS 100 DIAS.....40
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....42
APÊNDICE A – CONTEÚDO DA PLANILHA DE TABELAS.....43
REFERÊNCIAS.....44

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo e contexto

Este estudo consolida, a partir exclusivamente de bases públicas (DATASUS/TABNET: SIH, SIA, CNES, SIM e SINASC; SIOPS/MS; IBGE/SIDRA; edital do concurso SESA 001/2026; legislação orçamentária divulgada pela Alap e pela imprensa), o retrato da produção assistencial, da rede física, da força de trabalho, do financiamento e dos indicadores vitais da saúde no Amapá na série histórica **2022–2026**: 2022 é o ano-base (último exercício da gestão anterior), 2023 a 2025 são os anos completos da gestão que se encerra e 2026 é o ano parcial (competências de janeiro a agosto no SIH/SIA, setembro no CNES e 4º bimestre no SIOPS). Há comparativos entre as unidades da federação para 2024–2025. Todas as tabelas de apoio estão na planilha *Tabelas_Saude_Amapa_Transicao_2026.xlsx* (129 abas), e os dados brutos e scripts de extração acompanham este documento para auditoria e reprocessamento.

O estudo destina-se à equipe de transição de governo do Estado do Amapá (posse em 6 de janeiro de 2027) e à futura direção da Secretaria de Estado da Saúde (SESA/AP), como instrumento de diagnóstico inicial e de priorização de ações. Não substitui as informações internas da Secretaria (contratos, filas de regulação, execução financeira), que devem ser solicitadas conforme a lista apresentada na seção 10.

1.2 Objeto

Produção hospitalar (SIH/SUS), produção ambulatorial (SIA/SUS), morbidade hospitalar, rede física e equipamentos (CNES), força de trabalho (CNES), mortalidade (SIM), nascimentos (SINASC), financiamento (SIOPS, LOA) e demografia (IBGE) do Estado do Amapá, com recortes por ano, mês, estabelecimento, município, região de saúde, procedimento, complexidade, gestão e esfera do prestador.

1.3 Período

Série histórica de 2022 a 2026: 2022 como ano-base, 2023–2025 como anos completos e 2026 parcial (competências de janeiro a agosto no SIH/SIA; setembro no CNES; 4º bimestre no SIOPS). Comparativos entre UFs para 2024 e 2025.

1.4 Fontes e extração

Todas as tabelas foram extraídas em 6/11/2026 diretamente do TABNET/DATASUS (arquivos *.def* por UF e nacionais), do SIOPS (consulta de indicadores de estados, despesa empenhada, 6º bimestre) e da API SIDRA do IBGE (tabela 6579). O edital do concurso foi lido do PDF oficial. Os scripts e os CSV brutos estão em *dados/* e *scripts/*.

1.5 Limitações

(a) O SIA estadual não permite tabulação por estabelecimento; (b) os repasses do Fundo Nacional de Saúde (ConsultaFNS), os portais estaduais (transparência, SESA) e os painéis de atenção primária (e-Gestor/SISAB) e vacinação (SI-PNI) não estavam acessíveis a partir do ambiente de extração, e seus dados devem ser requisitados à SESA na transição; (c) valores em reais correntes, sem deflação; (d) dados de 2025 do SIM/SINASC são preliminares; (e) a série populacional do IBGE tem quebra entre o Censo 2022 e as estimativas pós-Censo (2024: 802.837; 2025: 806.517; 2026: 809.953), por isso taxas per capita são calculadas apenas para 2024–2026; (f) o CNES conta indivíduos, que podem ter mais de um vínculo.

2 SÍNTESE DOS ACHADOS

Os dez achados centrais do levantamento são apresentados a seguir e detalhados nas seções 3 a 8.

1) **A produção SUS cresceu fortemente, mas o valor médio por internação é o menor do país.** As internações passaram de 41.312 AIH (2022) para 57.873 (2025), alta de 40,1%, e o valor hospitalar de R$ 35,9 milhões para R$ 54,5 milhões (+51,7%). Mesmo assim, o valor médio da AIH no Amapá (R$ 942) é o mais baixo das 27 UFs (Brasil: R$ 1.760), e o gasto hospitalar SUS por habitante (R$ 67,6) é o 26º. Apenas 2,3% das internações são de alta complexidade: o estado interna muito, mas interna procedimentos de baixa densidade tecnológica, e a alta complexidade continua sendo buscada fora do estado.
2) **A produção ambulatorial quase dobrou em valor em três anos.** O SIA/SUS saltou de R$ 77,0 milhões (2022) para R$ 148,7 milhões (2025), +93,3%, e de 7,5 milhões para 16,5 milhões de procedimentos (+119,8%). Em 2026 (jan–ago) já soma R$ 115,5 milhões, ritmo anualizado de cerca de R$ 173 milhões. O gasto ambulatorial SUS por habitante (R$ 154 em 2024) está acima da média nacional (R$ 149) e é o 7º do país.
3) **Há uma anomalia de faturamento em procedimentos vasculares que exige auditoria imediata.** O subgrupo "terapias especializadas" (praticamente todo em "tratamento esclerosante não estético de varizes") saiu de R$ 15 mil em 2022 para R$ 10,9 milhões em 2023, R$ 21,8 milhões em 2024 e R$ 25,6 milhões em 2025 (84.885 procedimentos), com R$ 18,6 milhões em jan–ago/2026. No mesmo movimento, as internações por doenças do aparelho circulatório passaram de 1.899 (2022) para 15.455 (2023) e 11.024 (2025), quase todas no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL), com 7.375 AIH de "trombectomia do sistema venoso" em 2025 (R$ 5,7 milhões) e permanência média de zero dias. O CBO "médico em cirurgia vascular" responde sozinho por R$ 29,9 milhões (20,1%) de todo o valor ambulatorial de 2025. Trata-se do principal ponto de atenção para controle interno, auditoria do SUS (DENASUS) e Tribunal de Contas.
4) **O Estado gasta muito em saúde por habitante e cumpre com folga o mínimo constitucional, mas a composição do gasto mudou.** Pelo SIOPS, o Amapá aplicou 16,80% da receita própria em ações e serviços públicos de saúde em

2025 (5º do país; 17,58% em 2024, 3º; 15,39% em 2022), e tem a maior despesa estadual com saúde por habitante do Brasil (R$ 2.889 em 2025, contra R$ 1.566 em 2022, alta de 84,5%; a mediana das UFs é R$ 1.009). A participação de pessoal caiu de 49,8% (2022) para 44,3% (2025), serviços de terceiros (pessoa jurídica) oscilam entre 21% e 27%, e a dependência de transferências subiu de 15,5% para 36,0% da despesa (41,8% no 4º bimestre de 2026). O Fundo Estadual de Saúde está em R$ 1,72 bilhão na LOA 2026 (13,8% do orçamento estadual) e em R$ 1,98 bilhão no PLOA 2027.

5) **A rede de leitos cresceu 15% desde 2022, mas é concentrada e tem inconsistências cadastrais relevantes.** São 1.663 leitos de internação (1.469 SUS) em set/2026 contra 1.412 (1.280 SUS) em dez/2022. Macapá concentra 1.013 leitos SUS (69%) e Santana 194; os outros 14 municípios somam 262. As UTIs adulto dobraram (68 leitos em dez/2022 para 139 em set/2026), mas apenas 19 estão cadastradas como SUS no CNES; em UTI pediátrica 31/20 e neonatal 53/40. A divergência entre "existente" e "SUS" sugere erro de cadastro ou leitos não habilitados, com impacto direto em financiamento federal e regulação.
6) **A força de trabalho cresceu mais de 50%, mas segue abaixo da média nacional e concentrada na capital.** Médicos cadastrados no CNES: 1.065 (dez/2022) para 1.636 (set/2026), +53,6%, ou 2,02 por mil habitantes (Brasil: 2,91; 22º lugar); 81% atuam em Macapá. Enfermeiros: 1.380 para 2.223 (+61%). O concurso SESA 001/2026 (4.210 vagas de cadastro de reserva, prova em 20/12/2026) chegará à nova gestão em fase de homologação, com decisão pendente sobre nomeações e substituição de vínculos temporários.
7) **Indicadores materno-infantis melhoraram em processo, mas a mortalidade infantil segue entre as três piores do país.** O pré-natal com 7 ou mais consultas passou de 49,6% (2022) para 60,3% (2025) dos nascidos vivos e a gravidez na adolescência caiu de 18,6% para 17,7%. Porém a taxa de mortalidade infantil foi de 17,8 por mil em 2024 (Brasil: 12,6; 3ª maior entre as UFs), após o pico de 20,9 em 2023, e 17,3 em 2025 (preliminar); 65% dos óbitos infantis de 2024 são por causas evitáveis, sobretudo ligadas à atenção à gestante e ao recém-nascido. A cesariana subiu de 38,8% para 46,9% dos partos.

8) **O Amapá é exportador de alta complexidade e importador de baixa complexidade.** Em 2025, os hospitais do Amapá realizaram 57.873 internações, enquanto os residentes do estado consumiram 55.555 (onde quer que tenham sido internados). O saldo é positivo em quantidade (atendimento a pacientes do Pará, em especial do arquipélago do Marajó), mas negativo em valor (R$ 56,1 milhões consumidos pelos residentes contra R$ 54,5 milhões produzidos no estado). O Tratamento Fora de Domicílio custou R$ 10,0 milhões em 2025 só em deslocamento e ajuda de custo registrados no SIA (R$ 9,3 milhões em 2022).
9) **A transição epidemiológica pressiona a rede.** As doenças do aparelho circulatório já são a primeira causa de morte (944 óbitos em 2024), seguidas de causas externas (701, com 257 agressões e 106 "intervenções legais") e neoplasias (594). As internações por doenças respiratórias (5.576 em 2025, 343 óbitos; 4.041 AIH de pneumonia/influenza com 232 óbitos) levaram ao decreto de emergência em saúde pública de junho de 2026. A oncologia ganhou radioterapia própria em dezembro de 2025; a nefrologia faz cerca de 54 mil sessões de hemodiálise/ano (equivalente a ~350 pacientes em programa).
10) **Dependência do prestador filantrópico e do HU.** O Hospital São Camilo e São Luís respondeu por 4.411 AIH e R$ 11,9 milhões em 2025 (21,8% do valor hospitalar, com o maior valor médio por AIH do estado e 74% das AIH de alta complexidade), e protagonizou em 2025 uma tentativa de rescisão unilateral dos contratos, suspensa judicialmente. O HU-UNIFAP (Ebserh) saiu de 23 AIH em 2022 para 2.371 em 2025, com 90 dos 212 leitos planejados abertos. A continuidade contratual com esses dois prestadores é item crítico dos primeiros 100 dias.

3 DEMOGRAFIA E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

3.1 População

O Amapá tem 806.517 habitantes (IBGE 2025), dos quais 489.676 (60,7%) em Macapá e 118.803 (14,7%) em Santana. Os dois municípios concentram três quartos da população, o que explica, mas não justifica integralmente, a concentração de leitos, médicos e produção na capital. Os 14 demais municípios têm entre 4 mil (Pracuúba, Cutias) e 38 mil (Laranjal do Jari) habitantes, com populações ribeirinhas, indígenas e de fronteira (Oiapoque) que elevam o custo logístico do cuidado.

Tabela 1 – População residente estimada por município, Amapá, 2025

Município	Pop. 2025	%
Macapá	489.676	60,7
Santana	118.803	14,7
Laranjal do Jari	37.872	4,7
Oiapoque	30.786	3,8
Mazagão	23.773	2,9
Porto Grande	19.048	2,4
Pedra Branca do Amapari	13.888	1,7
Tartarugalzinho	13.816	1,7
Vitória do Jari	11.899	1,5
Calçoene	11.461	1,4
Amapá	**8.440**	**1,0**
Ferreira Gomes	7.184	0,9
Itaubal	6.097	0,8
Serra do Navio	5.003	0,6
Cutias	4.723	0,6
Pracuúba	4.048	0,5
Amapá	**806.517**	**100**

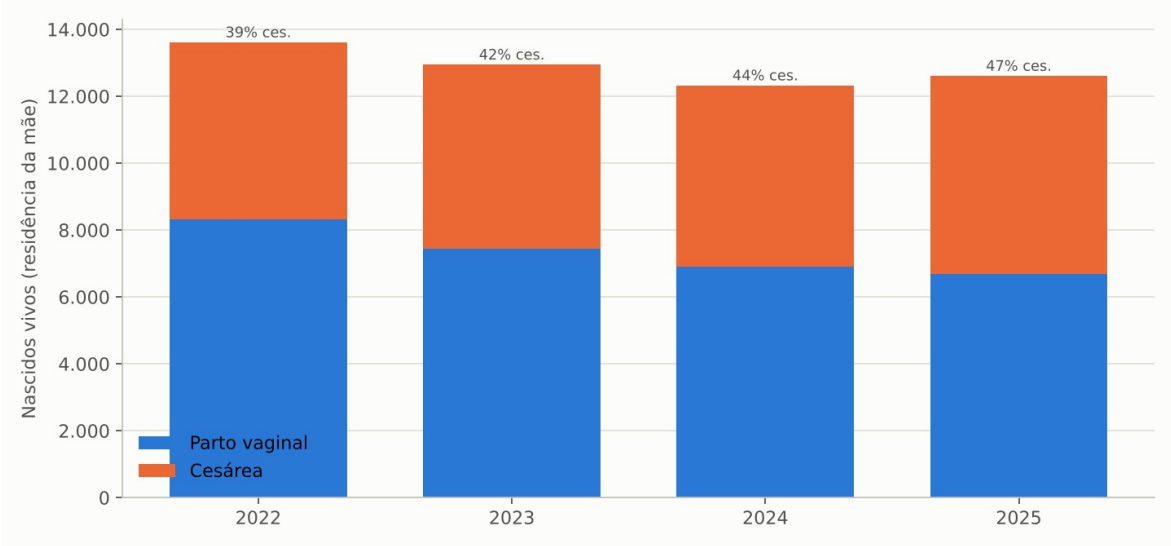
Fonte: IBGE/SIDRA, tabela 6579 (aba *POP_Municipios*).

3.2 Nascimentos e saúde materno-infantil

Os nascidos vivos de mães residentes caíram de 13.615 (2022) para 12.612 (2025), queda de 7,4%, consistente com a transição demográfica. A qualidade do pré-natal avançou: 60,3% dos nascidos vivos de 2025 tiveram 7 ou mais consultas (49,6% em 2022), e a proporção de mães de 10 a 19 anos caiu de 18,6% para 17,7%. Em contrapartida, a cesariana passou de 38,8% para 46,9% dos partos; pela classificação de Robson (2024), o grupo 5 (cesárea anterior) já responde por 2.217

nascimentos, 1.737 deles por nova cesárea, e o grupo 2 (nulíparas com indução ou cesárea antes do trabalho de parto) tem 77% de cesáreas.

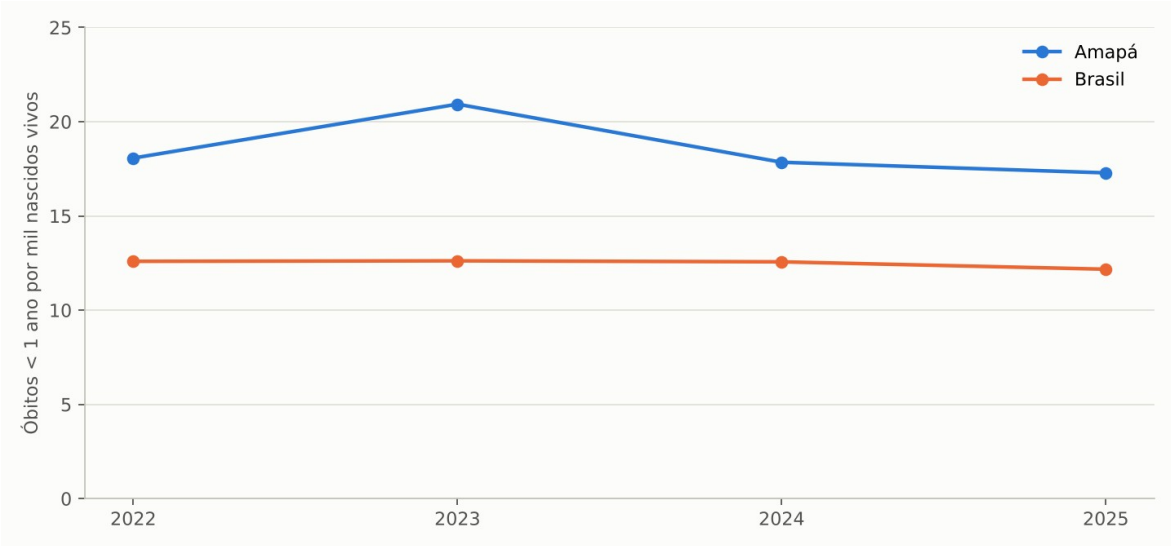
Figura 1 – Nascidos vivos por tipo de parto, Amapá, 2022–2025



Fonte: elaboração própria a partir de SINASC/DATASUS (BRASIL, 2026).

A mortalidade infantil é o indicador mais sensível e mais preocupante: 17,8 óbitos por mil nascidos vivos em 2024 (220 óbitos), 3ª maior taxa entre as UFs (Brasil: 12,6), depois do pico de 20,9 em 2023 (271 óbitos), e 17,3 em 2025 (218 óbitos, dado preliminar). Do total de 2024, 144 óbitos (65%) foram classificados como evitáveis, dos quais 63 reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação, 18 por atenção ao parto e 26 por atenção ao recém-nascido. O componente neonatal precoce (0 a 6 dias) concentra cerca de metade dos óbitos infantis.

Figura 2 – Taxa de mortalidade infantil, Amapá e Brasil, 2022–2025



Fonte: elaboração própria a partir de SIM e SINASC/DATASUS (BRASIL, 2026).

Tabela 2 – Indicadores materno-infantis selecionados, Amapá, 2022–2025

Ano	Nascidos vivos	Óbitos < 1 ano	TMI (por mil)	% cesáreas	% 7+ consultas pré-natal	% mães 10–19 anos
2022	13.615	246	18,1	38,8	49,6	18,6
2023	12.948	271	20,9	42,5	51,2	18,5
2024	12.327	220	17,8	43,9	55,5	17,5
2025*	12.612	218	17,3	46,9	60,3	17,7

preliminar. Fonte: SINASC/SIM (abaVITAL_00_Indicadores).

3.3 Mortalidade geral e causas

Foram 3.846 óbitos de residentes em 2022, 3.926 em 2023, 3.903 em 2024 e 3.988 em 2025 (preliminar). O perfil de causas (2024) é o de um estado em transição epidemiológica acelerada: doenças do aparelho circulatório 944 (infarto 276, AVC 281), causas externas 701 (agressões 257, contra 385 em 2023; intervenções legais 106; acidentes de transporte 99), neoplasias 594, doenças respiratórias 468 (pneumonia 266), infecciosas 226 e diabetes 177. As causas mal definidas representam 5,4% dos óbitos (Brasil: 5,1%), aceitável, mas com margem de melhoria na investigação. Em 2025 os óbitos por doenças respiratórias (521) e circulatórias (953) seguem em alta.

4 PRODUÇÃO HOSPITALAR (SIH/SUS)

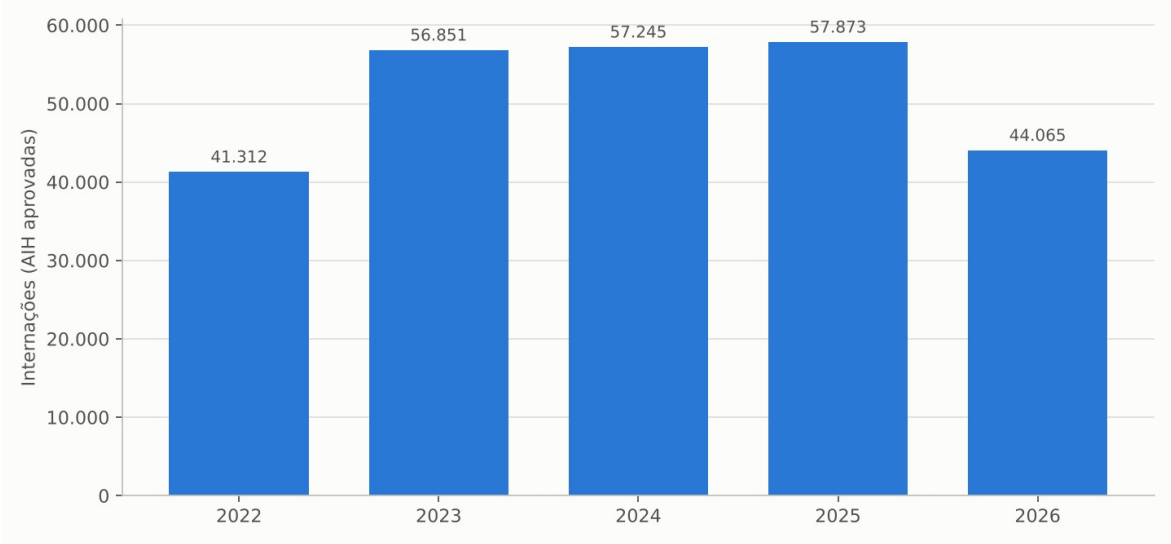
4.1 Série histórica

Tabela 3 – Internações SUS no Amapá por ano de processamento, 2022–2026

Ano	AIH aprovadas	Valor total (R$)	Valor médio AIH (R$)	Média perm. (dias)	Óbitos	Tx. mortalidade (%)
2022	41.312	35.931.724	870	5,2	1.308	3,17
2023	56.851	47.548.618	836	4,4	1.529	2,69
2024	57.245	49.734.245	869	4,9	1.434	2,51
2025	57.873	54.508.025	942	4,7	1.443	2,49
2026 (jan–ago)	44.065	54.393.607	1.234	4,8	1.184	2,69
Var. 2022–2025	+40,1%	+51,7%	+8,3%	—	+10,3%	—

Fonte: SIH/SUS, AIH por ano de processamento, local de internação (aba *SIH_01_Ano*).

Figura 3 – Internações SUS (AIH aprovadas), Amapá, 2022–2026



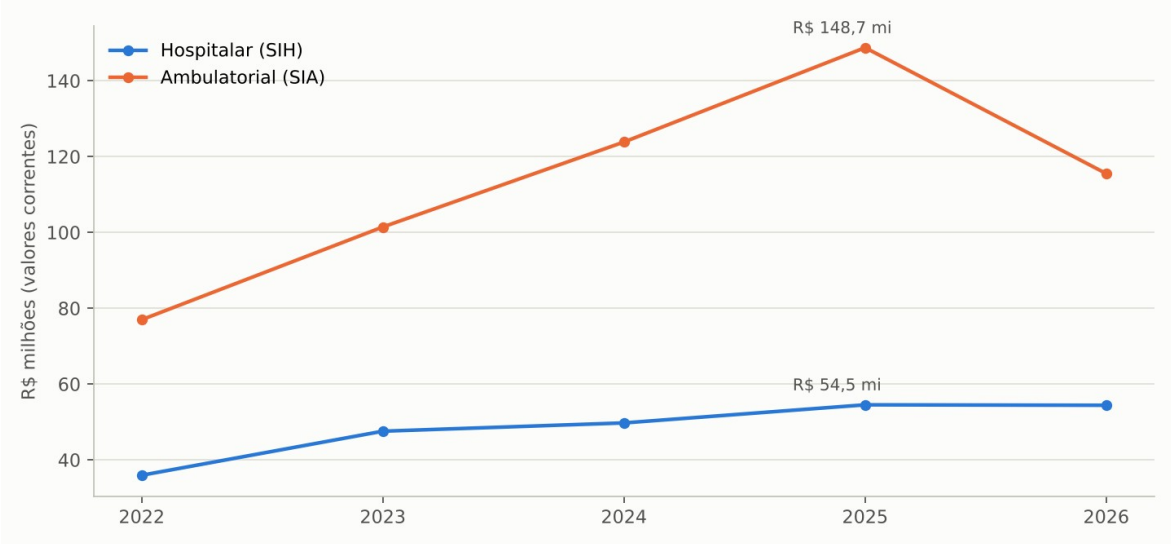
Fonte: elaboração própria a partir de SIH/SUS/DATASUS (BRASIL, 2026).

Três movimentos marcam a série: (i) o degrau de 2023, quando as internações sobem 38% em um ano (de 41,3 mil para 56,9 mil), explicado quase integralmente pelo HCAL (de 3.737 para 15.446 AIH) e por procedimentos eletivos (de 8.743 para 20.205), e não por urgências; (ii) a estabilidade de 2024–2025 em torno de 57 mil internações, com o valor crescendo pela mudança de perfil (mais cirurgias, mais FAEC); (iii) a aceleração do valor em 2026: nos oito primeiros meses o faturamento (R$ 54,4 milhões) já iguala o ano inteiro de 2025, com valor médio da AIH subindo para R$ 1.234, puxado pelo HCAL (R$ 17,5 milhões em oito meses, contra R$ 9,5 milhões em todo o 2025) e por FAEC (R$ 21,7 milhões em

jan–ago/2026 contra R$ 13,0 milhões em 2025 e R$ 0,9 milhão em 2022), o que indica a entrada dos programas federais de cirurgias eletivas.

Os eletivos passaram de 21,2% das AIH em 2022 (8.743) para 32,8% em 2025 (18.982). As urgências somam 38.889 AIH (67,2%).

Figura 4 – Valor aprovado da produção hospitalar e ambulatorial, Amapá, 2022–2026



Fonte: elaboração própria a partir de SIH/SUS e SIA/SUS/DATASUS (BRASIL, 2026).

4.2 Produção por estabelecimento

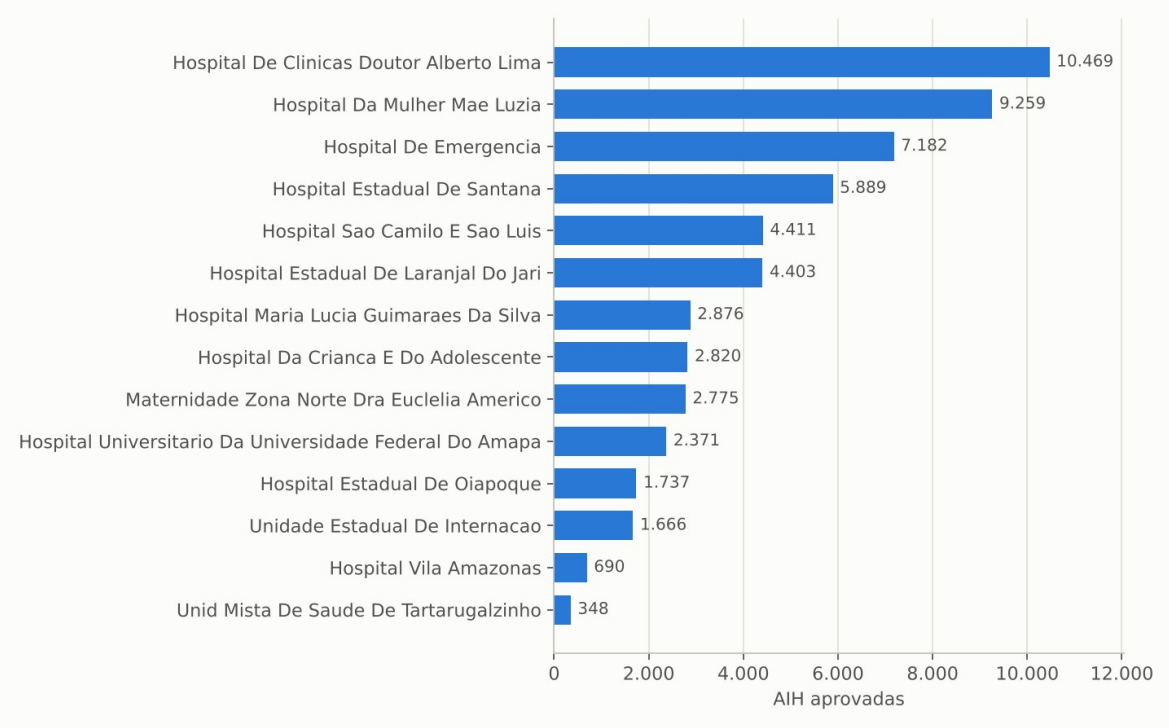
Tabela 4 – Produção hospitalar por estabelecimento, Amapá, 2022, 2025 e 2026

Estabelecimento	AIH 2022	AIH 2025	Var. 22–25	Valor 2025 (R$)	Média perm. 2025	Óbitos 2025	Tx. mort. 2025 (%)	AIH jan–ago/2026
Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL)	3.737	10.469	+180%	9.518.556	2,8	263	2,51	9.559
Hospital da Mulher Mãe Luzia	12.848	9.259	−28%	10.500.831	4,9	75	0,81	6.929
Hospital de Emergência (HE)	3.245	7.182	+121%	6.321.203	7,2	276	3,84	6.096
Hospital Estadual de Santana	4.872	5.889	+21%	2.999.034	5,4	195	3,31	4.203
Hospital São Camilo e São Luís (filantrópico)	4.967	4.411	−11%	11.899.992	3,4	40	0,91	2.532
Hospital Estadual de Laranjal do Jari	4.203	4.403	+5%	2.119.920	2,1	79	1,79	2.828
Hospital Maria Lúcia G. da Silva (Porto Grande)	293	2.876	+882%	1.504.336	1,8	4	0,14	1.834
Hospital da Criança e do Adolescente (HCA)	1.833	2.820	+54%	3.681.675	8,4	56	1,99	2.399
Maternidade Zona Norte Dra. Euclélia Américo	716	2.775	+288%	1.367.493	2,1	0	0,00	2.038
HU-UNIFAP (Ebserh)	23	2.371	—	2.102.931	8,3	115	4,85	1.909
Hospital Estadual de Oiapoque	1.711	1.737	+2%	735.197	3,0	21	1,21	1.180
Unidade Estadual de	—	1.666	—	955.949	10,5	241	14,47	1.524

Estabelecimento	AIH 2022	AIH 2025	Var. 22–25	Valor 2025 (R$)	Média perm. 2025	Óbitos 2025	Tx. mort. 2025 (%)	AIH jan–ago/2026
Internação (desde 2025)								
Hospital Vila Amazonas (Santana)	15	690	—	287.764	6,8	12	1,74	28
Unidades mistas e UPAs (9 unidades em 2022, 8 em 2025)	2.659	1.117	−58%	408.671	—	7	—	635
Hospital Marco Zero (desde 2025)	—	208	—	104.472	8,4	59	28,37	371
Hospitais de campanha COVID (encerrados)	190	—	—	—	—	—	—	—
Total	**41.312**	**57.873**	**+40%**	**54.508.025**	**4,7**	**1.443**	**2,49**	**44.065**

Fonte: SIH/SUS (abas *SIH_estab_2025*, *SIH_estab_2026*, *SIH_estab_ano_aih*, *SIH_estab_ano_valor*).

Figura 5 – Internações (AIH) por estabelecimento, Amapá, 2025



Fonte: elaboração própria a partir de SIH/SUS/DATASUS (BRASIL, 2026).

Leituras relevantes para a transição:

– **HCAL** virou o maior produtor de AIH do estado (10.469 em 2025; 9.559 em jan–ago/2026) com 100% de internações eletivas e permanência de 2,8 dias; 7.624 das suas AIH de 2025 são do capítulo de doenças circulatórias (ver seção 9.1). É também o hospital com maior crescimento de faturamento em 2026 (anualizado em R$ 26 milhões, contra R$ 4,4 milhões em 2022).

– **HE** mais que dobrou as internações desde 2022 e tem a maior permanência média entre os grandes (7,2 dias) e 276 óbitos/ano; é o principal nó da rede de

urgência, com o novo HE em obras (anexo de 30 leitos entregue em junho/2026).

– **Mãe Luzia** perdeu 28% das internações desde 2022 (consolidação da Maternidade Zona Norte, que quase quadruplicou, e queda dos nascimentos), mas ainda é o maior faturamento público (R$ 10,5 milhões), com 1.327 internações de afecções perinatais.

– **São Camilo** concentra alta complexidade (992 das 1.341 AIH de alta complexidade do estado, 74%) e tem valor médio de R$ 2.698 por AIH, quase o triplo da média estadual: é o prestador que mais pesa por internação. A relação contratual sofreu ruptura em 2025 (notificação de rescisão unilateral, suspensa por decisão judicial), as AIH caíram 11% desde 2022 e em jan–ago/2026 somam apenas 2.532 (ritmo anual de 3,8 mil).

– **HU-UNIFAP** passou de produção residual em 2022 para 2.371 AIH em 2025, com perfil clínico-cirúrgico de maior permanência (8,3 dias) e mortalidade (4,85%).

– **Unidade Estadual de Internação** (criada em 2025) e **Hospital Marco Zero** apresentam mortalidade de 14,5% e 28,4%, compatíveis com perfis de cuidados prolongados/paliativos ou de retaguarda clínica de pacientes graves. Vale revisar o perfil assistencial, a habilitação e o registro.

– **UPAs e unidades mistas** reduziram as internações registradas de 2.657 (2022) para 1.117 (2025): a UPA Zona Sul deixou de registrar AIH (1.463 em 2022, 1.682 em 2023, 35 em 2025, zero em 2026) e as unidades mistas do interior internam pouco (61 a 348 AIH/ano cada), o que mostra uma rede do interior de baixa resolutividade e que drena pacientes para Macapá: 71,2% das internações e 87,8% do valor ambulatorial do estado ocorrem na capital.

4.3 Perfil de morbidade

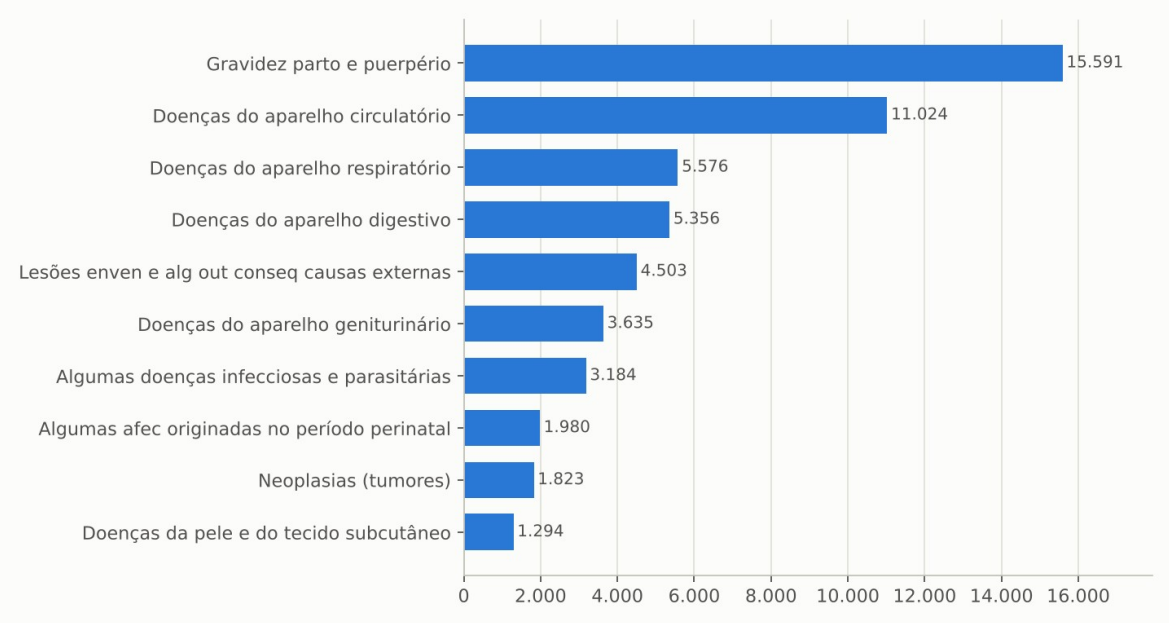
Tabela 5 – Internações por capítulo da CID-10, Amapá, 2022 e 2025

Capítulo CID-10	Intern. 2022	Intern. 2025	Valor 2025 (R$)	Média perm. 2025	Óbitos 2025	Tx. mort. 2025 (%)
XV. Gravidez, parto e puerpério	16.643	15.591	8.233.813	2,9	6	0,04
IX. Aparelho circulatório	1.899	11.024	15.514.668	2,3	279	2,53
X. Aparelho respiratório	4.775	5.576	5.779.172	7,9	343	6,15
XI. Aparelho digestivo	3.725	5.356	4.364.505	4,8	133	2,48
XIX. Lesões e causas externas	2.442	4.503	3.402.927	5,2	59	1,31

Capítulo CID-10	Intern. 2022	Intern. 2025	Valor 2025 (R$)	Média perm. 2025	Óbitos 2025	Tx. mort. 2025 (%)
XIV. Aparelho geniturinário	2.279	3.635	2.176.373	5,9	79	2,17
I. Infecciosas e parasitárias	2.644	3.184	2.836.877	7,3	203	6,38
XVI. Afecções perinatais	2.395	1.980	6.159.656	8,7	70	3,54
II. Neoplasias	1.422	1.823	1.809.399	6,0	130	7,13
XII. Pele e subcutâneo	811	1.294	519.561	5,8	14	1,08
Demais	2.277	3.907	3.711.074	—	127	—
Total	**41.312**	**57.873**	**54.508.025**	**4,7**	**1.443**	**2,49**

Fonte: SIH/SUS, morbidade hospitalar (abas *MORB_cap_ano*, *MORB_cap_2025*).

Figura 6 – Internações por capítulo da CID-10, Amapá, 2025



Fonte: elaboração própria a partir de SIH/SUS/DATASUS (BRASIL, 2026).

A obstetrícia responde por 27% das internações (parto normal 6.835; cesariana 5.374), o que explica a baixa mortalidade hospitalar agregada do Amapá (2,49%, a menor do país; Brasil 4,34%). Descontado o capítulo XV, a taxa sobe para 3,4%. As doenças respiratórias têm a maior carga de óbitos (343; 232 só em pneumonia/influenza) e permanência longa (7,9 dias); em jan–ago/2026 já são 4.319 internações e 296 óbitos, ritmo acima de 2025, coerente com o decreto estadual de emergência por síndromes respiratórias de junho de 2026. As internações de menores de 1 ano (3.725) e de 1 a 4 anos (2.429) somam 10,6% do total, com forte predomínio respiratório (1.040 e 1.282 AIH, respectivamente): a pediatria é o gargalo sazonal da rede (HCA com 192 leitos após ampliação em 2026). As internações por causas externas quase dobraram (2.442 para 4.503) e as do aparelho digestivo

cresceram 44%, refletindo a expansão de cirurgia geral (colecistectomia, hernioplastia, apendicectomia).

4.4 Fluxo de pacientes: residência versus local de internação

Tabela 6 – Internações de residentes do Amapá e internações realizadas no Amapá, 2022–2025

Ano	AIH de residentes do AP (qualquer UF)	AIH realizadas no AP	Saldo (AIH)	Valor residentes (R$)	Valor realizado no AP (R$)	Saldo (R$)
2022	39.793	41.312	+1.519	36.457.453	35.931.724	−525.729
2023	55.036	56.851	+1.815	49.556.840	47.548.618	−2.008.222
2024	55.111	57.245	+2.134	51.450.674	49.734.245	−1.716.429
2025	55.555	57.873	+2.318	56.067.200	54.508.025	−1.559.176

Fonte: SIH/SUS por UF de residência e por UF de internação (aba *SIH_Residencia_x_Local*).

O Amapá recebe mais internações do que seus residentes consomem (saldo de +2.318 AIH em 2025, essencialmente pacientes paraenses do Marajó e do baixo Amazonas atendidos em Macapá e Santana), mas o saldo financeiro é negativo em R$ 1,6 milhão: as internações de amapaenses fora do estado são de alta complexidade e custo (cardiologia intervencionista, neurocirurgia, oncologia cirúrgica, transplantes). Esse fluxo, somado ao TFD (R$ 10,0 milhões/ano em passagens aéreas e ajuda de custo, seção 5.3), é a medida objetiva do vazio assistencial de alta complexidade. A gestão estadual plena concentra 100% das AIH desde 2024 (o Pacto de Gestão municipal de Porto Grande deixou de registrar AIH).

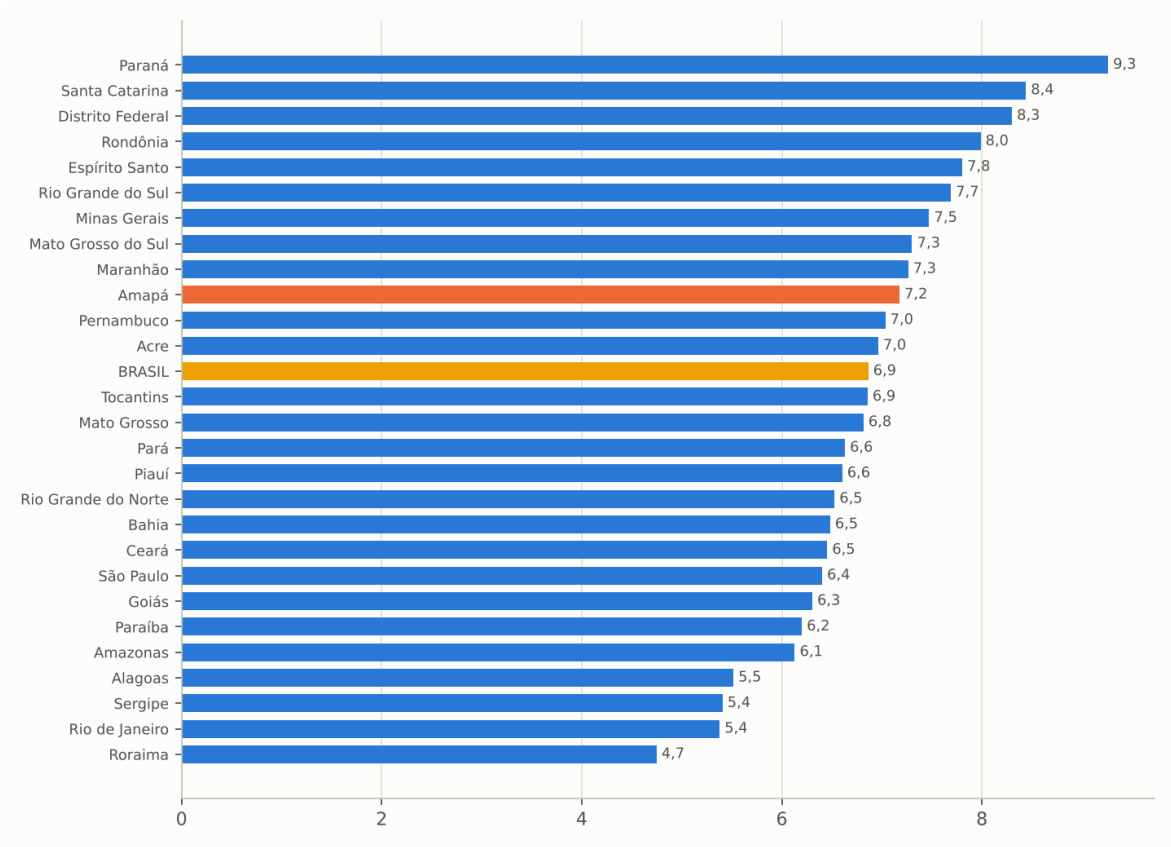
4.5 Comparativo entre UFs

Tabela 7 – Indicadores de produção hospitalar e ambulatorial: Amapá, Brasil e posição entre as UFs, 2024–2025

Indicador (2025)	Amapá	Brasil	Posição do AP (27 UFs)
Internações SUS por 100 hab.	7,18	6,86	10º
Valor SIH por habitante (R$)	67,6	120,8	26º
Valor médio da AIH (R$)	942	1.760	27º (menor)
Média de permanência (dias)	4,7	5,0	—
Taxa de mortalidade hospitalar (%)	2,49	4,34	27º (menor)
% AIH de alta complexidade	2,3	—	—
Valor SIA por habitante, 2024 (R$)	154	149	7º

Fonte: SIH/SIA por UF e IBGE (aba *BENCH_UF*).

Figura 7 – Internações SUS por 100 habitantes, por UF de internação, 2025



Fonte: elaboração própria a partir de SIH/SUS/DATASUS e IBGE (BRASIL, 2026).

A combinação "muitas internações, valor médio mínimo, pouca alta complexidade" é a assinatura de uma rede que resolve o básico e o obstétrico, mas depende de Belém, Brasília e São Paulo para o restante. Entre os estados da Região Norte, o Amapá tem valor médio de AIH abaixo de Acre (R$ 1.038), Rondônia (R$ 1.152), Amazonas (R$ 1.215), Pará (R$ 1.279), Tocantins (R$ 1.291) e Roraima (R$ 1.311).

5 PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SIA/SUS)

5.1 Série histórica

Tabela 8 – Produção ambulatorial SUS no Amapá por ano de processamento, 2022–2026

Ano	Procedimentos aprovados	Valor aprovado (R$)	Valor apresentado (R$)
2022	7.490.015	76.958.762	85.238.415
2023	10.178.221	101.419.804	101.758.460
2024	13.424.826	123.836.722	124.370.832
2025	16.460.498	148.724.442	148.994.309
2026 (jan–ago)	10.959.853	115.512.295	114.289.628
Var. 2022–2025	+119,8%	+93,3%	+74,8%

Fonte: SIA/SUS por ano de processamento, local de atendimento (aba *SIA_01_Ano*).

O valor ambulatorial quase dobrou entre 2022 e 2025 e a quantidade mais que dobrou, com crescimento em todos os anos da série. A gestão estadual plena responde por R$ 120,9 milhões (81%) em 2025, contra R$ 68,5 milhões em 2022, e o Pacto de Gestão municipal (Macapá, Santana e demais) por R$ 27,9 milhões (R$ 8,4 milhões em 2022). Por fonte: MAC R$ 102,5 milhões, FAEC R$ 43,5 milhões (R$ 18,2 milhões em 2022) e assistência farmacêutica (componente especializado) R$ 2,7 milhões. Por instrumento de registro: BPA-C R$ 53,8 milhões, BPA-I R$ 64,2 milhões e APAC R$ 30,7 milhões.

5.2 Composição por subgrupo e procedimento

Tabela 9 – Valor aprovado da produção ambulatorial por subgrupo de procedimento, Amapá, 2022 e 2025

Subgrupo	Valor 2022 (R$)	Valor 2025 (R$)	Var. 22–25	% do valor 2025	Quantidade 2025
0301 Consultas / atendimentos / acompanhamentos	15.989.257	31.867.081	+99%	21,4	8.510.597
0309 Terapias especializadas (angiologia)	15.280	25.557.699	×1.673	17,2	113.164
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	8.059.051	15.849.791	+97%	10,7	3.928.199
0305 Tratamento em nefrologia	10.376.160	13.371.816	+29%	9,0	54.700
0803 Autorização / regulação (TFD: deslocamento e ajuda de custo)	9.313.297	10.038.443	+8%	6,7	109.715
0206 Diagnóstico por tomografia	1.932.923	10.013.538	+418%	6,7	86.329
0211 Métodos diagnósticos em especialidades	6.917.096	6.674.788	−4%	4,5	356.147
0304 Tratamento em oncologia	1.832.317	5.007.235	+173%	3,4	5.349
0401 Pequenas cirurgias / pele	111.225	4.955.318	×45	3,3	163.283

Subgrupo	Valor 2022 (R$)	Valor 2025 (R$)	Var. 22–25	% do valor 2025	Quantidade 2025
0405 Cirurgia do aparelho da visão	11.104.027	4.881.070	−56%	3,3	12.378
0207 Ressonância magnética	2.122.319	3.161.223	+49%	2,1	11.762
0604 Componente especializado da assistência farmacêutica	933.729	2.652.940	+184%	1,8	1.352.259
0205 Ultrassonografia	682.829	2.609.081	+282%	1,8	72.622
0204 Radiologia	1.902.507	2.594.329	+36%	1,7	264.638
0212 Hemoterapia (diagnóstico)	2.074.748	2.340.940	+13%	1,6	104.342
Demais	3.591.997	7.149.150	+99%	4,8	1.315.014
Total	**76.958.762**	**148.724.442**	**+93%**	**100**	**16.460.498**

Fonte: SIA/SUS (abas *SIA_subgrupo_ano_valor*, *SIA_subgrupo_2025*).

Os dez procedimentos de maior valor em 2025 mostram onde está o dinheiro ambulatorial: tratamento esclerosante de varizes (84.885 procedimentos, R$ 25,5 milhões), hemodiálise (51.777 sessões, R$ 12,5 milhões), atendimento de urgência em atenção especializada (885.863, R$ 9,7 milhões), consulta de nível superior não médico (1.477.497, R$ 9,3 milhões), curativo grau II (148.471, R$ 4,8 milhões), deslocamento aéreo de paciente e de acompanhante no TFD (R$ 4,5 e R$ 4,0 milhões), facoemulsificação com lente intraocular (5.081, R$ 3,9 milhões), observação de urgência até 24 h (308.514, R$ 3,8 milhões) e consulta médica especializada (335.097, R$ 3,3 milhões).

Por CBO do executante, "médico em cirurgia vascular" lidera com R$ 29,9 milhões (20,1% de todo o SIA), seguido por médico clínico (R$ 27,3 milhões), radiologista (R$ 16,9 milhões), biomédico (R$ 16,5 milhões), nefrologista (R$ 13,6 milhões) e oftalmologista (R$ 12,1 milhões).

5.3 Linhas de cuidado de alto custo

– **Nefrologia.** R$ 13,4 milhões e cerca de 54 mil sessões de hemodiálise em 2025 (51.777 convencionais e 2.247 em sorologia positiva), o equivalente a aproximadamente 350 pacientes em programa regular. A linha cresceu 29% desde 2022 (R$ 10,4 milhões), com 115 a 132 equipamentos de diálise cadastrados no CNES a partir de 2025.

– **Oncologia.** R$ 5,0 milhões em quimioterapia (SIA) em 2025, contra R$ 1,8 milhão em 2022 (+173%), mais R$ 0,3 milhão em internações clínicas oncológicas (493 AIH com 24% de mortalidade) e cirurgia oncológica (77 AIH). O Centro de Radioterapia do Amapá iniciou em dezembro de 2025 e, até agosto de 2026,

registrava 305 primeiras consultas e 235 simulações, com braquiterapia a partir de junho de 2026; sua produção ainda aparece pouco no SIA (subgrupo "atenção em oncologia", R$ 309 mil em jan–ago/2026) e deve ser acompanhada.

– **Oftalmologia.** R$ 11,1 milhões em 2022 (mutirões de catarata), queda para R$ 1,8 milhão em 2024, retomada para R$ 4,9 milhões em 2025 mais R$ 1,2 milhão nas novas "ofertas de cuidado integrado" (OCI) oftalmológicas, e R$ 6,6 milhões mais R$ 4,0 milhões de OCI em jan–ago/2026, indicando nova rodada de mutirão em 2026 (programa "Zera Fila").

– **Tratamento Fora de Domicílio.** R$ 10,0 milhões em 2025 em deslocamento aéreo de paciente (R$ 4,5 milhões) e acompanhante (R$ 4,0 milhões) e ajudas de custo (R$ 1,4 milhão), contra R$ 9,3 milhões em 2022. O TFD é, junto com o saldo negativo de internações fora do estado, o custo visível da ausência de alta complexidade.

– **Imagem.** Tomografia R$ 10,0 milhões (86 mil exames), cinco vezes o valor de 2022, e ressonância R$ 3,2 milhões (11,8 mil exames); o estado possui 27 tomógrafos e 15 ressonâncias em uso, mas apenas 4 tomógrafos e 1 ressonância na esfera estadual (seção 6.3), o que explica a dependência de prestadores privados contratados.

5.4 Distribuição territorial

Macapá concentra 87,8% do valor ambulatorial (R$ 130,5 milhões em 2025, contra R$ 66,4 milhões em 2022) e Santana 5,3% (R$ 7,8 milhões). A Região de Saúde Norte (Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho) produz apenas R$ 2,9 milhões (1,9%) e a Sudoeste R$ 11,7 milhões (7,9%). Porto Grande saltou de R$ 250 mil (2024) para R$ 2,7 milhões (2025), e o Hospital Maria Lúcia Guimarães da Silva passou de 85 para 2.876 AIH no mesmo período, indicando a implantação de um polo regional; vale verificar se o salto é produção real ou mudança de registro.

6 REDE FÍSICA E EQUIPAMENTOS (CNES)

6.1 Estabelecimentos

Em setembro de 2026 o CNES registra 1.196 estabelecimentos no Amapá (867 em dezembro de 2022): 20 hospitais gerais (15 da administração estadual, 1 empresa pública federal — HU-UNIFAP/Ebserh —, 3 empresariais e 1 filantrópico), 3 hospitais especializados (todos estaduais), 5 pronto-atendimentos (3 estaduais), 153 centros de saúde/UBS e 65 postos de saúde (municipais), 34 policlínicas, 156 clínicas de especialidade, 84 SADT isolados, 12 CAPS (2 estaduais), 1 hemocentro, 2 centrais de regulação do acesso estaduais, 20 unidades de saúde indígena (federais) e 432 consultórios isolados privados. Sob gestão estadual estão 68 estabelecimentos; os demais 1.128 estão sob gestão municipal. O crescimento do cadastro entre 2022 e 2026 vem sobretudo de consultórios isolados (306 para 432), clínicas de especialidade (93 para 156), policlínicas (11 para 34) e farmácias (21 para 81).

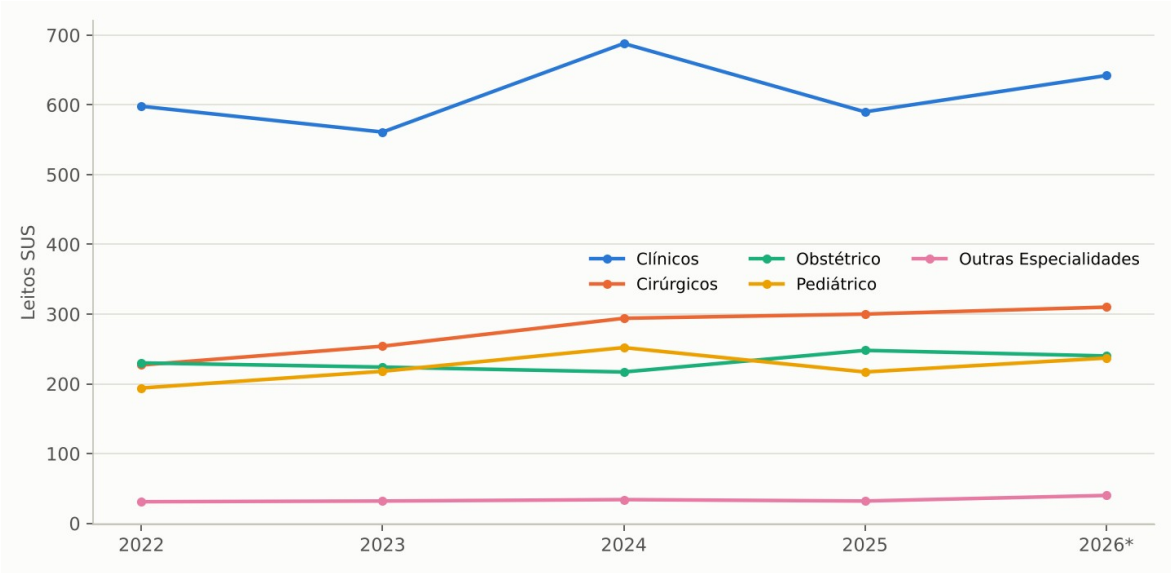
6.2 Leitos

Tabela 10 – Leitos de internação SUS por especialidade, Amapá, dez./2022 a set./2026

Especialidade	Leitos SUS dez/2022	dez/2023	dez/2024	dez/2025	set/2026	Existentes set/2026
Clínicos	598	561	688	590	642	748
Cirúrgicos	227	254	294	300	310	350
Obstétricos	230	224	217	248	240	249
Pediátricos	194	218	252	217	237	276
Outras especialidades (psiquiatria, crônicos)	31	32	34	32	40	40
Total	**1.280**	**1.289**	**1.485**	**1.387**	**1.469**	**1.663**

Fonte: CNES (abas *CNES_leitos_esp_ano*, *CNES_leitos_esp_ano_sus*).

Figura 8 – Leitos de internação SUS por especialidade, Amapá, 2022–2026



Fonte: elaboração própria a partir de CNES/DATASUS (BRASIL, 2026).

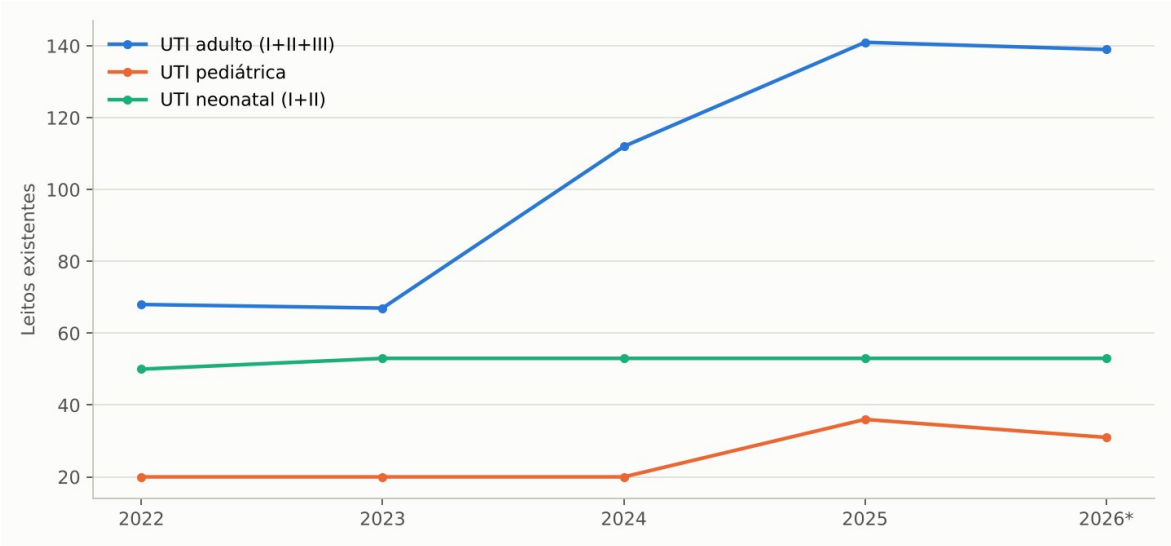
Os leitos SUS cresceram 14,8% entre dezembro de 2022 e setembro de 2026 (1,81 leitos SUS por mil habitantes), com expansão concentrada em leitos cirúrgicos (+37%) e pediátricos (+22%), oscilação dos clínicos (pico de 688 em 2024, queda em 2025, recuperação em 2026) e estabilidade dos obstétricos. A capital tem 1.013 leitos SUS (69%), Santana 194 (13%), Laranjal do Jari 74, Oiapoque 51 e os demais municípios entre 10 e 21 cada. Pela esfera jurídica, 1.163 leitos SUS estão em unidades da administração estadual, 90 no HU, 161 em prestadores empresariais e 55 no filantrópico (que tem 207 leitos existentes, apenas 55 SUS).

Tabela 11 – Leitos complementares existentes e SUS, Amapá, dez./2022 e set./2026

Leitos complementares	Existentes dez/2022	Existentes set/2026	SUS set/2026
UTI adulto (tipos I, II e III)	68	139	19
UTI pediátrica (tipo II)	20	31	20
UTI neonatal (tipo II)	50	53	40
UCI neonatal convencional / canguru	45 / 15	49 / 18	44 / 13
Unidade de isolamento	19	26	25
UCI adulto	8	6	5
Total	**231**	**322**	**166**

Fonte: CNES (abas *CNES_uti_tipo_ano*, *CNES_uti_tipo_ano_sus*). Em dez/2022 ainda havia 6 leitos de unidade intermediária neonatal, extintos depois.

Figura 9 – Leitos de UTI existentes, Amapá, 2022–2026



Fonte: elaboração própria a partir de CNES/DATASUS (BRASIL, 2026).

As UTIs adulto dobraram (68 leitos em dez/2022 para 139 em set/2026, com salto em 2024–2025), e as pediátricas passaram de 20 para 31. Porém o CNES mostra apenas 19 leitos de UTI adulto cadastrados como SUS (53 existentes em hospitais estaduais, 10 no HU, 50 em empresariais e 20 no filantrópico). Essa divergência, de 120 leitos, tende a ser um problema de cadastro (campo "leitos SUS" não preenchido) ou de habilitação: em ambos os casos compromete o custeio federal de UTI (diárias habilitadas), a regulação e a transparência. Em leitos complementares SUS por 100 mil habitantes o Amapá (20,5) iguala a média nacional (20,7), mas a composição interna está distorcida pela subnotificação da UTI adulto; a recomendação é um censo de leitos e conciliação CNES x habilitações nos primeiros 60 dias.

6.3 Equipamentos

Tabela 12 – Equipamentos selecionados cadastrados no CNES, Amapá, set./2026

Equipamento (set/2026)	Existentes	Em uso	Estabelecimentos com equipamento SUS	Em uso na esfera estadual
Tomógrafo computadorizado	27	27	17	4
Ressonância magnética	15	15	11	1
Mamógrafo	27	26	11	1
Raio X	293	283	93	28
Ultrassom	250	244	85	25
Equipo odontológico completo	580	561	161	21

Fonte: CNES (abas *CNES_equip_sel_latest*, *CNES_equip_sel_esfjur_latest*).

O parque de imagem de alta densidade está majoritariamente no setor privado (18 dos 27 tomógrafos, 11 das 15 ressonâncias, 15 dos 26 mamógrafos), o que torna o Estado comprador de exames e sustenta os R$ 13,2 milhões anuais de tomografia e ressonância no SIA. O total de equipamentos em uso cadastrados subiu de 6.226 (dez/2022) para 10.382 (set/2026), com destaque para equipamentos de manutenção da vida (1.323 para 2.650) e o novo grupo de diálise (132).

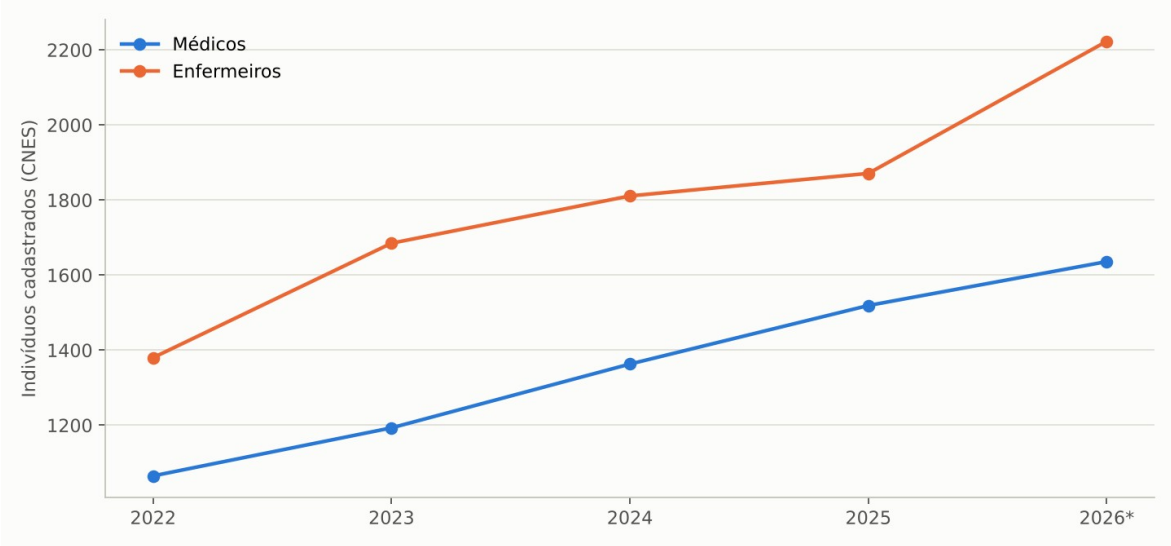
7 FORÇA DE TRABALHO

Tabela 13 – Profissionais de saúde cadastrados no CNES por ocupação, Amapá, dez./2022 a set./2026

Profissionais (indivíduos, CNES)	dez/2022	dez/2023	dez/2024	dez/2025	set/2026	Var. 22–26
Médicos	1.065	1.193	1.363	1.519	1.636	+54%
Enfermeiros	1.380	1.685	1.811	1.871	2.223	+61%
Fisioterapeutas	521	549	579	638	731	+40%
Farmacêuticos	231	269	300	322	350	+52%
Cirurgiões-dentistas (total)	563	574	595	639	692	+23%
Nível superior (total)	5.126	5.836	6.487	7.186	8.019	+56%
Técnicos de enfermagem (set/2026)	—	—	—	—	5.091	—
Todas as ocupações	15.622	17.732	18.931	20.431	22.155	+42%

Fonte: CNES (abas *CNES_prof_medicos_ano*, *CNES_prof_sup_ano*, *CNES_prof_geral_ano*, *CNES_prof_tec_latest*).

Figura 10 – Médicos e enfermeiros cadastrados no CNES, Amapá, 2022–2026



Fonte: elaboração própria a partir de CNES/DATASUS (BRASIL, 2026).

O número de médicos cresceu 54% desde 2022, mas a densidade (2,02 por mil habitantes) segue abaixo da média nacional (2,91) e é a 22ª entre as UFs; 1.332 médicos (81%) atuam em Macapá, 82 em Santana, 60 em Laranjal do Jari, 39 em Porto Grande, 37 em Oiapoque e entre 3 e 15 nos demais municípios. Entre as especialidades, destacam-se 560 clínicos, 205 médicos de família, 114 pediatras, 71 obstetras, 53 radiologistas, 51 cirurgiões gerais, 45 cardiologistas, 44 anestesistas, 22 cirurgiões vasculares e 13 psiquiatras. Dos 8.019 profissionais de nível superior,

3.560 (44%) estão vinculados à administração estadual, 2.812 à municipal, 279 ao HU e cerca de 1.300 ao setor privado/filantrópico.

Concurso público SESA 001/2026. Publicado em 11/9/2026 (Instituto AOCP), com 4.210 vagas de cadastro de reserva para o Grupo Saúde sob regime estatutário (Lei 0066/1993, PCCS Lei 1.059/2006 reestruturado pelas Leis 3.512/2026 e 3.527/2026), distribuídas por Região de Saúde: Central 2.552, Norte 637 e Sudoeste 1.021, com lotação mínima de três anos no município. Os maiores quantitativos são técnico em enfermagem (904 só na Região Central) e enfermeiro (786), além de cerca de 150 vagas médicas em 46 especialidades na Região Central. Vencimentos básicos: R$ 11.116,42 (médicos), R$ 5.520,64 (demais nível superior) e R$ 3.363,43 (nível médio/técnico). Inscrições encerradas em 13/10/2026; prova objetiva em 20/12/2026. A nova gestão herdará a homologação, o dimensionamento de nomeações (o edital é só cadastro de reserva) e a estratégia de substituição de contratos temporários, com impacto direto no indicador de despesa com pessoal (44,3% em 2025).

8 FINANCIAMENTO

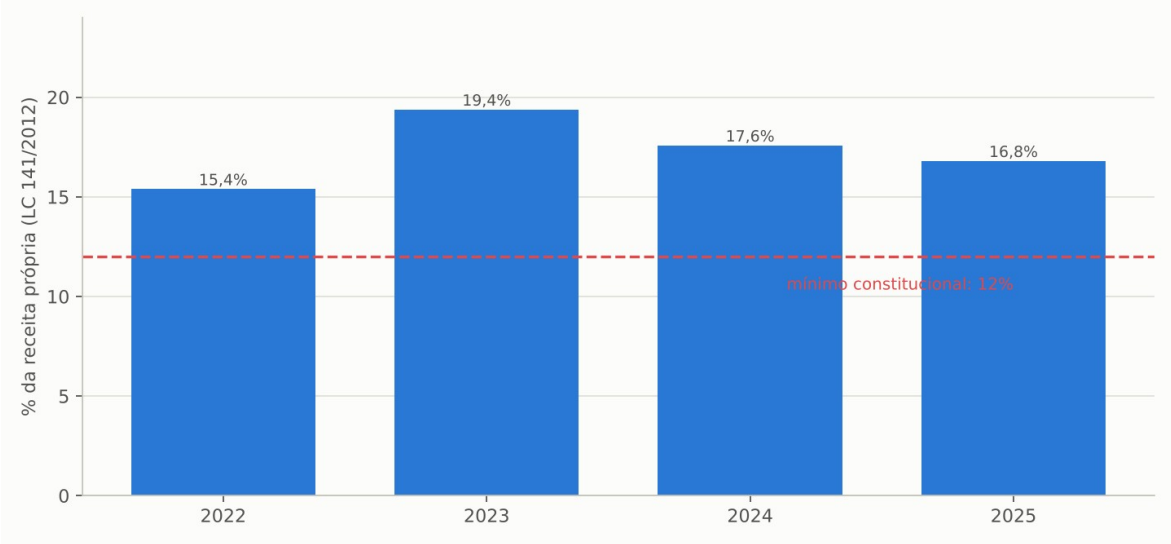
8.1 SIOPS: indicadores do Estado

Tabela 14 – Indicadores SIOPS do Estado do Amapá, 2022–2026

Indicador SIOPS (Estado do Amapá)	2022	2023	2024	2025	2026 (4º bim.)
3.2 % da receita própria aplicada em ASPS (mín. 12%)	15,39	19,38	17,58	16,80	15,34
2.1 Despesa com saúde por habitante (R$)	1.566	2.034	2.666	2.889	1.940
2.2 % pessoal na despesa com saúde	49,8	55,3	47,8	44,3	44,3
2.4 % serviços de terceiros, pessoa jurídica	27,1	24,4	25,1	20,9	22,6
2.5 % investimentos	4,1	3,0	8,5	4,8	2,0
2.3 % medicamentos	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1 % transferências na despesa com saúde	15,5	22,9	26,0	36,0	41,8
1.3 % transferências SUS no total transferido ao Estado	3,7	6,6	7,8	11,1	11,1

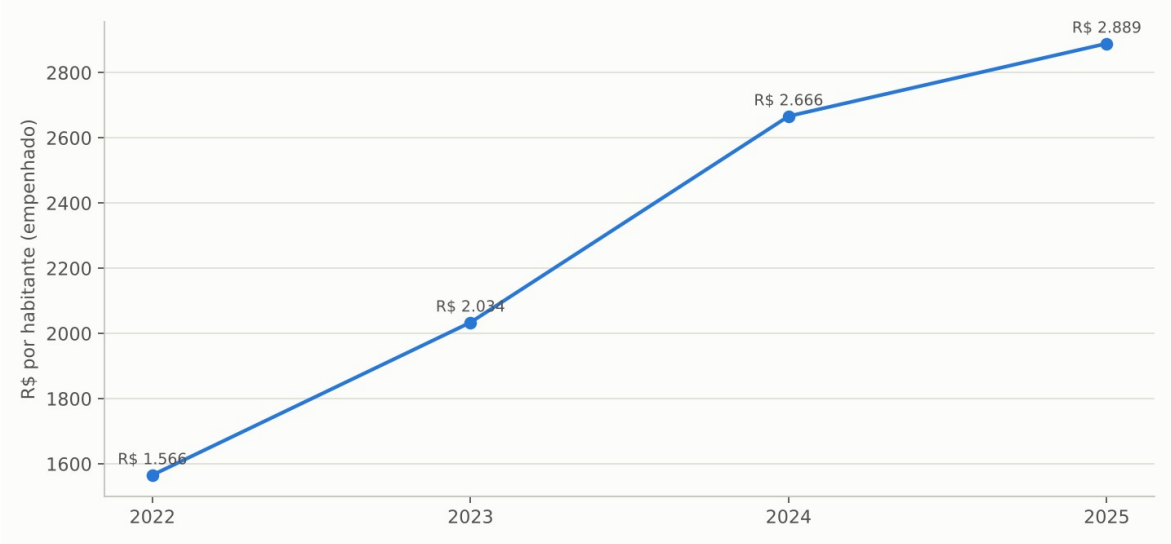
Fonte: SIOPS/MS, despesa empenhada (abas *SIOPS_AP_Serie*, *SIOPS_UF_2024*, *SIOPS_UF_2025*).

Figura 11 – Percentual da receita própria aplicada em ASPS, Estado do Amapá, 2022–2025



Fonte: elaboração própria a partir de SIOPS/Ministério da Saúde (BRASIL, 2026).

Figura 12 – Despesa do Estado com saúde por habitante, Amapá, 2022–2025



Fonte: elaboração própria a partir de SIOPS/Ministério da Saúde (BRASIL, 2026).

Quatro pontos: (i) o Estado cumpre o mínimo constitucional com folga em toda a série e está entre os cinco que mais aplicam receita própria (3º em 2024, 5º em 2025; a mediana das UFs é 15,4%); (ii) a despesa por habitante cresceu 84,5% em três anos e é a maior do país em 2024 e 2025 (a segunda, Acre, gasta R$ 2.760; a mediana é R$ 1.009), o que combina pequena população, custo amazônico e rede estadualizada (o Estado gere todos os hospitais, enquanto em outras UFs há forte presença municipal e filantrópica); (iii) a queda da participação de pessoal de 49,8% para 44,3%, simultânea ao salto das transferências federais na despesa (de 15,5% para 36% em 2025 e 41,8% em 2026) e à alta do peso do SUS no total transferido ao Estado (de 3,7% para 11,1%), mostra que o crescimento recente do gasto foi financiado sobretudo por recursos federais (emendas, FAEC, programas de eletivas e de UTI) e por contratos de serviços, e não por expansão do quadro próprio; (iv) o indicador de medicamentos zerado desde 2023 é incompatível com a operação de uma rede hospitalar e indica classificação contábil inadequada da despesa com medicamentos (possivelmente dentro de "material de consumo" ou de contratos), ponto a corrigir na prestação de contas.

8.2 Orçamento estadual e recursos federais

– **LOA 2026:** R$ 12,425 bilhões para o Estado; Fundo Estadual de Saúde com R$ 1,72 bilhão (13,8% da LOA). **PLOA 2027** (em tramitação na Alap): R$ 13,47

bilhões, com FES em R$ 1,98 bilhão (+15,3%). Valores de fonte secundária (Alap e imprensa), a confirmar na lei publicada.

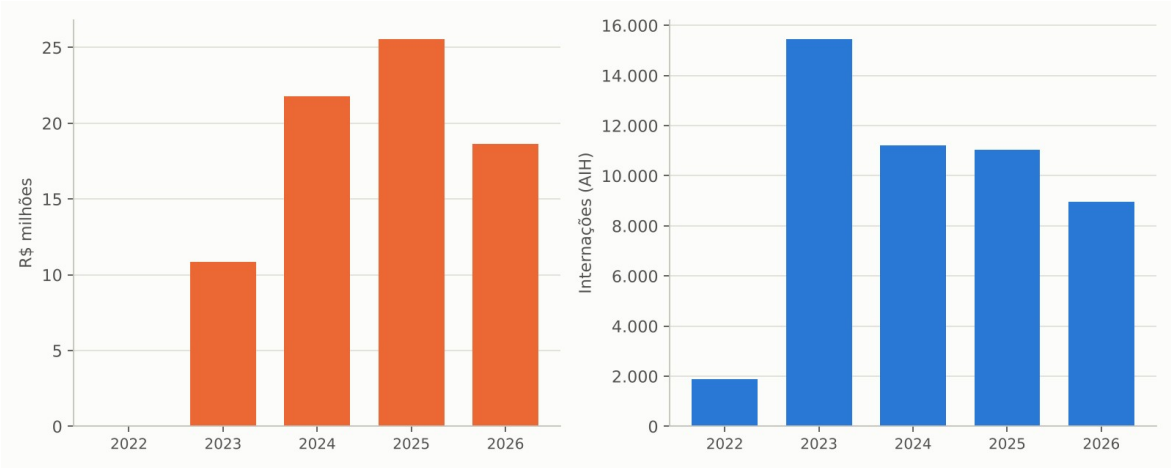
– **Produção remunerada pelo SUS (MAC/FAEC):** o valor aprovado da produção hospitalar e ambulatorial somou R$ 203,2 milhões em 2025 (R$ 54,5 milhões SIH e R$ 148,7 milhões SIA), contra R$ 112,9 milhões em 2022 (+80%). O FAEC passou de R$ 19,2 milhões (2022) para R$ 56,5 milhões (2025: R$ 13,0 milhões SIH e R$ 43,5 milhões SIA) e já soma R$ 65,4 milhões em jan–ago/2026. Como o teto MAC é transferido fundo a fundo independentemente da produção, esse valor é uma referência do "faturamento" e não do repasse; a diferença entre teto e produção deve ser obtida na SESA/FNS.

– **Lacuna de informação:** os repasses do FNS por bloco (manutenção e estruturação) e por esfera, os restos a pagar, as despesas por unidade hospitalar e os contratos de gestão e de prestação de serviços não estão em bases públicas acessíveis e devem compor a lista de documentos da transição (seção 10).

9 PONTOS DE ATENÇÃO PARA A TRANSIÇÃO

9.1 Procedimentos vasculares: crescimento atípico de faturamento (prioridade máxima)

Figura 13 – Procedimentos vasculares: valor ambulatorial e internações circulatórias, Amapá, 2022–2026



Fonte: elaboração própria a partir de SIA/SUS e SIH/SUS/DATASUS (BRASIL, 2026).

Resumo da evidência: (a) SIA, subgrupo 0309 "terapias especializadas": R$ 15 mil (2022), R$ 10,9 milhões (2023), R$ 21,8 milhões (2024), R$ 25,6 milhões (2025), R$ 18,6 milhões (jan–ago/2026), quase integralmente no procedimento 03.09.07.001-5 (esclerose não estética de varizes, 84.885 registros em 2025); (b) SIH, capítulo IX: 1.899 internações (2022) para 15.455 (2023), 11.226 (2024), 11.024 (2025) e 8.973 (jan–ago/2026), das quais 7.624 no HCAL em 2025 e 7.375 AIH de "trombectomia do sistema venoso" com permanência média 0,0 dia; (c) CBO cirurgia vascular com R$ 29,9 milhões (20,1% do SIA) executados por 22 cirurgiões vasculares cadastrados; (d) o HCAL, com 100% de internações eletivas, tornou-se o maior produtor de AIH do estado e dobrou o faturamento em 2026. Cada um desses elementos pode ter explicação assistencial (programa estadual de varizes com demanda represada), mas a magnitude (R$ 39 milhões em 2025 somando SIA e SIH, mais do que toda a produção hospitalar de 2022) e as características de registro (AIH de permanência zero, volumes diários implausíveis para 22 profissionais) justificam auditoria técnica e operativa imediata, com verificação de prontuários, agendas, listas de regulação, contratos e vínculos dos executantes, e comunicação ao DENASUS e ao TCE-AP. Enquanto a auditoria não concluir,

recomenda-se não usar esse faturamento como base para contratualização ou metas.

9.2 Cadastro de leitos e habilitações

A diferença entre leitos existentes e leitos SUS em UTI (139 contra 19 em adulto) e a presença de 207 leitos existentes com apenas 55 SUS no prestador filantrópico exigem conciliação entre CNES, portarias de habilitação e contratos. Leitos de UTI habilitados geram custeio federal por diária; leitos não habilitados ou mal cadastrados são receita perdida e regulação cega.

9.3 Relações com prestadores estratégicos

São Camilo e São Luís (filantrópico; 74% da alta complexidade hospitalar do estado; conflito contratual judicializado em 2025; produção em queda em 2026) e HU-UNIFAP/Ebserh (90 de 212 leitos abertos; 2.371 AIH em 2025; contratualização com a SESA a verificar) são os dois prestadores cujas condições contratuais, débitos e metas precisam ser mapeados antes da posse. O mesmo vale para os contratos de imagem (tomografia e ressonância) e de nefrologia, majoritariamente privados.

9.4 Rede de urgência, sazonalidade respiratória e pediatria

A emergência em saúde pública por síndromes respiratórias (decreto de junho de 2026, 180 dias, com contratações diretas) vence no início da nova gestão e deve ser avaliada quanto à continuidade dos contratos emergenciais. O HE é o principal ponto de pressão (7.182 internações, 7,2 dias de permanência, 276 óbitos) e tem obra em curso (novo HE). A pediatria (HCA, 192 leitos) e as UTIs pediátricas (31 existentes, 20 SUS) são o gargalo sazonal. As UPAs deixaram de registrar internações e as unidades mistas do interior têm produção residual: a regionalização prevista no edital do concurso (lotação por Região de Saúde) é uma oportunidade de fixar equipes fora de Macapá.

9.5 Mortalidade infantil e atenção materna

Com TMI de 17,8 por mil (2024) e 65% dos óbitos infantis evitáveis, o estado precisa de um plano de redução com metas por maternidade (Mãe Luzia,

Maternidade Zona Norte, Santana, Laranjal do Jari, Oiapoque), investigação de 100% dos óbitos infantis e fetais, vigilância da cesariana (46,9%) e integração com a atenção primária municipal (pré-natal e puericultura).

9.6 Alta complexidade e TFD

O menor valor médio de AIH do país, 2,3% de alta complexidade, saldo negativo de R$ 1,6 milhão em internações fora do estado e R$ 10 milhões anuais de TFD mostram o custo de não ter cardiologia intervencionista plena, neurocirurgia e oncologia cirúrgica suficientes. A radioterapia (dez/2025) é o primeiro passo; a agenda inclui habilitação de serviços de alta complexidade (cardiovascular, neurocirurgia, oncologia cirúrgica, transplante renal) com o Ministério da Saúde e avaliação de consórcio ou contrato interestadual com Belém.

9.7 Pessoal

Decidir o volume de nomeações do concurso 001/2026, a substituição de temporários, o impacto na folha (indicador 2.2 em 44%) e a fixação regional. O crescimento do quadro desde 2022 (médicos +54%, enfermeiros +61%) não reduziu a concentração em Macapá.

10 RECOMENDAÇÕES E AGENDA DOS PRIMEIROS 100 DIAS

Documentos a requisitar imediatamente à SESA (equipe de transição):

1) Execução orçamentária e financeira do FES 2025 e 2026 por ação e por unidade; restos a pagar processados e não processados; passivos com fornecedores e prestadores (inclusive São Camilo, HU e serviços de imagem e diálise).
2) Teto MAC, portarias FAEC e repasses fundo a fundo 2022–2026 (ConsultaFNS), com a comparação entre produção aprovada (SIH/SIA) e valor transferido.
3) Contratos de gestão, de prestação de serviços e credenciamentos vigentes, com metas, vigência, aditivos e situação de pagamento; contratos emergenciais do decreto de junho/2026.
4) Relatório da regulação: filas por especialidade e por procedimento (SISREG e sistema estadual), tempo médio de espera, TFD interestadual (pacientes, destinos, custo), leitos regulados e taxa de ocupação por hospital.
5) Censo de leitos (existentes, operacionais, habilitados, bloqueados) e conciliação com CNES e habilitações do MS.
6) Relatórios de auditoria interna, do DENASUS e do TCE-AP sobre produção ambulatorial e hospitalar de 2023–2026, com destaque para procedimentos vasculares.
7) Quadro de pessoal por vínculo (efetivo, temporário, terceirizado, cedido), por unidade e por categoria; folha mensal; cronograma do concurso 001/2026.
8) Situação das obras (novo HE, HCA, unidades do interior), com percentuais físicos e financeiros, e dos equipamentos em implantação (radioterapia, imagem, diálise).
9) Estoque e consumo de medicamentos e insumos estratégicos (inclusive oncologia, componente especializado e emergência respiratória), e a conciliação contábil que explica a despesa com medicamentos zerada no SIOPS.
10) Plano Estadual de Saúde 2024–2027, Programação Anual de Saúde 2026 e Relatórios Detalhados do Quadrimestre, para medir a execução de metas.

Prioridades de gestão sugeridas (ordem de urgência):

1) Instaurar auditoria especial sobre os procedimentos vasculares (SIA 0309 e SIH 0406) e sobre o HCAL, com suspensão cautelar de novas autorizações acima da média histórica até conclusão.

2) Pactuar com São Camilo e HU-UNIFAP a continuidade dos serviços de alta complexidade enquanto se renegociam contratos e metas; mapear riscos de descontinuidade de diálise e imagem.
3) Realizar o censo de leitos e corrigir o CNES (UTI SUS), buscando habilitações federais pendentes.
4) Lançar um plano de redução da mortalidade infantil e da cesariana com metas por maternidade e comitês de investigação.
5) Preparar o plano de inverno respiratório 2027 (leitos pediátricos, oxigênio, vacinação, contratos) antes de março.
6) Definir a política de pessoal pós-concurso, com lotação regional e metas de fixação no interior; revisar terceirizações em face da queda de participação de pessoal no gasto.
7) Estruturar a agenda de alta complexidade (cardiologia intervencionista, neurocirurgia, oncologia cirúrgica, transplante renal) e revisar o TFD com critérios e auditoria.
8) Recompor a resolutividade do interior (unidades mistas, UPAs) com protocolos, telessaúde e transporte sanitário, usando a regionalização do concurso.
9) Instituir painel mensal de produção, fila, leitos e gasto por unidade, publicado no portal da transparência, como instrumento de governança da nova gestão.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O período 2022–2026 foi de forte expansão quantitativa da produção SUS no Amapá: mais internações, mais procedimentos ambulatoriais, mais leitos, mais profissionais e mais gasto por habitante. A expansão, porém, não alterou a assinatura estrutural da rede, que continua a resolver o básico e o obstétrico e a depender de outros estados para a alta complexidade, e veio acompanhada de sinais que exigem verificação imediata: o faturamento atípico de procedimentos vasculares, a subnotificação de leitos de UTI no CNES, a fragilidade das relações com os prestadores filantrópico e universitário e a persistência da mortalidade infantil entre as mais altas do país. A equipe de transição dispõe, com este estudo e com a planilha que o acompanha, de uma linha de base auditável para pactuar metas, redirecionar contratos e priorizar as decisões dos primeiros cem dias.

APÊNDICE A – CONTEÚDO DA PLANILHA DE TABELAS

A aba *Indice* lista as 129 abas com hiperlinks; todas as séries estão recortadas para 2022–2026. Grupos: *00_Indicadores_Chave* (painel-resumo); *POP_** (IBGE); *SIH_** (33 abas: séries, estabelecimentos, municípios, regiões, caráter, complexidade, gestão, esfera, procedimentos, financiamento, residência x local); *MORB_** (morbidade por CID, faixa etária, sexo, estabelecimento); *SIA_** (23 abas: séries, subgrupos, procedimentos, CBO, municípios, regiões, gestão, financiamento, instrumento de registro); *CNES_** (27 abas: leitos, UTI, estabelecimentos, equipamentos, profissionais); *VITAL_** (SIM e SINASC, 20 abas, com indicadores sintéticos); *BENCH_** (comparativos entre UFs); *SIOPS_** (série do Estado e ranking das UFs em 2024 e 2025); *RH_Concurso_2026*; *Fontes_Notas*.

REFERÊNCIAS

AMAPÁ. Assembleia Legislativa. **Alap aprova Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2026**. Macapá: Alap, 27 dez. 2025. Disponível em: https://www.diariodoamapa.com.br/cadernos/politica/alap-aprova-lei-orcamentaria-anual-para-o-exercicio-financeiro-de-2026/. Acesso em: 6 nov. 2026.

AMAPÁ. Secretaria de Estado da Administração; Secretaria de Estado da Saúde. **Edital de Concurso Público nº 001/2026**: abertura de inscrições para cargos do Quadro de Pessoal da Saúde Estadual. Macapá: SEAD; SESA; Instituto AOCP, 11 set. 2026.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Estimativas da população residente para os municípios e para as unidades da federação**: tabela 6579. Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/6579. Acesso em: 6 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)**: recursos físicos (leitos de internação e complementares, equipamentos), estabelecimentos e recursos humanos – Amapá. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026a. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?cnes/cnv/leiintap.def. Acesso em: 6 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)**: produção ambulatorial por local de atendimento – Amapá e Brasil por UF. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026b. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sia/cnv/qaap.def. Acesso em: 6 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)**: produção hospitalar por local de internação e por local de residência; morbidade hospitalar – Amapá e Brasil por UF. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026c. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/qiap.def. Acesso em: 6 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)**: óbitos por residência e óbitos infantis – Amapá e Brasil por UF. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026d. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10ap.def. Acesso em: 6 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)**: nascidos vivos por residência da mãe – Amapá e Brasil por UF. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026e. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvap.def. Acesso em: 6 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)**: consulta de indicadores dos estados, Amapá, 2015–2026. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026f. Disponível em: http://siops.datasus.gov.br/consdetalhereenvio2uf.php. Acesso em: 6 nov. 2026.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **No Amapá, Dr. Furlan (PSD) é o novo governador do estado**. Brasília, DF: TSE, out. 2026. Disponível em: https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/no-amapa-dr-furlan-psd-e-o-novo-governador-do-estado. Acesso em: 6 nov. 2026.

CONASS. **Centro de Radioterapia do Amapá mantém fluxo constante de atendimentos e reforça cuidado humanizado**. Brasília, DF: Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 2026. Disponível em: https://www.conass.org.br/centro-de-radioterapia-do-amapa-mantem-fluxo-constante-de-atendimentos-e-reforca-cuidado-humanizado/. Acesso em: 6 nov. 2026.

CONECTAMAPÁ. **Governo do Amapá decreta emergência em saúde pública por avanço de síndromes respiratórias**. Macapá, jun. 2026. Disponível em: https://conectamapa.com/governo-do-amapa-decreta-emergencia-em-saude-publica-por-avanco-de-sindromes-respiratorias/. Acesso em: 6 nov. 2026.

CORREIO DA MANHÃ. **Amapá amplia assistência clínica com entrega de 30 novos leitos**. Rio de Janeiro, jun. 2026. Disponível em: https://www.correiodamanha.com.br/nacional/norte/2026/06/296563-amapa-amplia-assistencia-clinica-com-entrega-de-30-novos-leitos.html. Acesso em: 6 nov. 2026.

DIÁRIO DO AMAPÁ. **Mensagem do governador Clécio prevê Orçamento de mais de R$ 13 bilhões para 2027**. Macapá, 2026. Disponível em: https://www.diariodoamapa.com.br/cadernos/politica/mensagem-do-governador-clecio-preve-orcamento-de-mais-de-r-13-bilhoes-para-2027/. Acesso em: 6 nov. 2026.

DIÁRIO DO PODER. **Decisão judicial freia ruptura hospitalar no Amapá; Governo acusa sabotagem**. Brasília, DF, 2025. Disponível em: https://diariodopoder.com.br/brasil-e-regioes/decisao-judicial-freia-ruptura-hospitalar-no-amapa-governo-acusa-sabotagem. Acesso em: 6 nov. 2026.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá. **Carta de Serviços ao Usuário**: abril de 2026. Macapá: Ebserh, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/hubrasil/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-norte/hu-unifap/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/CartadeServiosHUUNIFAPAbrilde2026.pdf. Acesso em: 6 nov. 2026.